

07 - 01- Révision de la Sémiologie gynécologique - Pr. FAKHIR

(0:00 - 1:31)

Il faut gagner du temps. D'accord, la première question, elle dit, d'où proviennent les caillots sanguins si le son des ménorrhées? Le son des démonstrations, c'est ça? Oui, oui. Madame, il dit, d'où proviennent les caillots sanguins si le son des ménorrhées est incoagulable? D'accord.

Alors, je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint maintenant. Vous voyez? Oui, madame. D'accord.

Alors, ce schéma-là, c'est un schéma qui reprend le cycle menstruel et qui nous montre ce qui se passe au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire l'épithélium à l'intérieur de la cavité utérine. D'accord? C'est ce qui est tout en bas. Donc, ça, c'est ce qui se passe au cours de tout le cycle.

(1:31 - 2:13)

Le cycle commence toujours le premier jour des règles et se termine à la fin du cycle, le début des règles suivantes. Donc, quand les règles surviennent, ce n'est pas uniquement du sang qui est extériorisé, mais aussi toute cette partie qui s'est développée au cours du cycle menstruel, c'est-à-dire qu'au tout début, l'endomètre, regardez l'épaisseur, elle est fine et au fur et à mesure, il augmente d'épaisseur. Ici, c'est la première phase préovulatoire, c'est la phase folliculaire.

(2:14 - 3:37)

Puis, au cours de la deuxième phase, qui est la phase butéale, il y a ce qu'on appelle la phase glandulaire, le développement des glandes endométriales. Et tout ceci pour préparer la réception d'un oeuf fécondé. D'accord.

Donc, les menstruations qui sortent, regardez vers la fin à droite, ce n'est pas uniquement un saignement, c'est aussi une désquamation de l'épithélium. Et donc, il y a des morceaux de l'épithélium qui sont extériorisés avec les menstruations et on a l'impression que ce sont des cailloux sanguins, or ce sont des morceaux, des lombos de l'endothélium. Généralement, il n'y a pas de cailloux sanguins, sauf quand la patiente a des problèmes de ménorrhagie, c'est-à-dire un saignement très abondant, et là, ça peut devenir du sang coagulé.

(3:40 - 5:11)

Regardez sur cet autre diapo l'évolution de cet endomètre. L'endomètre, c'est cette partie qu'on retrouve ici, c'est un épithélium qui couvre toute la cavité endométriale. Donc, il est fin, puis il devient de plus en plus épais et toute cette partie va s'extérioriser et va désquamer au cours des menstruations.

D'accord? Vous avez une autre question? Madame, quelqu'un pose la question, c'est quoi la

parité? C'est quoi la parité? Très bien. La parité, normalement, quand on fait un interrogatoire avec une patiente en gynécologie et en obstétrique, on pose la question sur le nombre de grossesses qu'elle a eues auparavant. D'accord? Et ça s'appelle la gestité.

Voilà, vous le trouvez sur ce diapo, regardez, sur cette diapositive. Vous la voyez maintenant? Oui. Alors, quand je pose des questions, je pose des questions sur la gestité, c'est le nombre de grossesses en totalité.

(5:12 - 5:28)

Combien cette patiente, elle a pu concevoir, quelle que soit l'issue de la grossesse. Et les différentes issues de la grossesse, c'est ce que vous avez par la suite ici. Alors, la parité, c'est le nombre d'accouchements au-delà de 20 semaines.

(5:28 - 6:15)

C'est-à-dire, si cette patiente, elle a eu, elle est deuxième geste, deuxième part, c'est qu'elle a eu deux grossesses, et ces deux grossesses ont abouti à deux accouchements, qui peuvent être à terme ou prématurés, mais en tout cas au-delà de 20 semaines. Ça s'appelle une parité. Par contre, si cette patiente, elle a eu deux, j'ai cité, donc elle est tombée enceinte deux fois, mais une des grossesses s'est soldée par une fausse couche, c'est-à-dire qu'elle a perdu la grossesse avant 20 semaines, et que la deuxième grossesse, elle est arrivée à terme, cela veut dire qu'on va dire qu'elle est deuxième geste, mais qu'elle est une part.

(6:15 - 7:43)

Elle a une seule parité, alors que la fausse couche va être comptabilisée comme fausse couche. D'accord? Est-ce que j'ai répondu? Madame? Oui? Pourquoi on considère 20 semaines d'améliorer? C'est une valeur de référence qui permet de séparer la grossesse en deux parties. En fait, c'est une valeur chronologique qui va obligatoirement sur base sur quelque chose de particulier, mais il paraît qu'avant 20 semaines, il y a beaucoup de phénomènes qui sont particuliers à cette période, par exemple la fonction rénale, par exemple la fin de la placentation, etc., et qu'au-delà de 20 semaines, il y a vraiment un changement, parce que là, c'est fin 2e et 3e trimestre, les reins fonctionnent différemment et commencent à fonctionner à partir de 20 semaines, il y a une émission d'urine qui constitue le liquide amniotique, et aussi au-delà de 20 semaines, on peut avoir des pathologies qui commencent à se manifester, comme par exemple l'hyperfonction artérielle et la grossesse.

(7:44 - 8:55)

Vous l'achetez à Gravidic. Donc, 20 semaines, c'est quand même une date qui permet de séparer tout ce qui est précoce, si vous voulez, et tout ce qui est tardif. D'accord, madame.

Merci. Très bien. Est-ce que vous avez une autre question? Comment peut-on utiliser un spéculum de vierge chez une fille qui est vierge? D'accord.

Alors, là, on ne le fait que très rarement, vraiment très rarement. En fait, je n'ai pas, je ne sais pas si j'avais l'image ou pas, voilà. En fait, c'est, voilà.

Donc, je viens de voir les commentaires sur votre écran. Donc, là, je pourrais suivre avec vous un peu mieux. Alors, regardez sur cette diapositive, en bas et à gauche, il y a l'image de trois types de spéculum.

(8:57 - 9:14)

Merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a trois types de spéculum et le tout petit qui est là, à droite, ça, on peut l'utiliser pour la vierge. Parce que tout simplement, l'hymen, ce n'est pas une membrane fermée.

(9:14 - 9:32)

C'est une membrane qui est ouverte, généralement, au centre. Et ça permet, est perméable et ça permet de faire évacuer les menstruations. Donc, il y a une sorte de trou, de petit trou avec une membrane tout autour.

(9:34 - 9:51)

Et ça, on l'a vu ensemble à l'anatomie, je pense, ou vous l'avez déjà vu à l'anatomie. Je vais essayer de vous trouver l'image. Donc, on peut utiliser ça pour ouvrir doucement sans rompre la membrane immédiate.

(9:51 - 10:29)

On retrouve ici, j'essaie de vous retrouver, on a eu un certain moment l'anatomie. Je vais essayer de vous trouver l'image de l'hymen, si j'arrive de la voir ici. Voilà.

(10:32 - 10:53)

Donc, on s'y sent un peu. Donc, l'hymen, c'est comme ça, naturellement, c'est comme ça. Et donc, c'est cette petite membrane qui est autour, qui est la membrane d'hymen.

(10:53 - 11:04)

Mais au centre, c'est ouvert. Et donc, on peut mettre un petit spéculum et regarder à l'intérieur. On ne fait plus ça parce que maintenant, on a des moyens endoscopiques.

(11:04 - 11:36)

Et on peut introduire comme l'hystéroscope, dont je vous ai très probablement parlé dans le cours des investigations. Alors, voilà l'hystéroscope, par exemple, comme celui-là, avec une caméra. Et on peut l'introduire à l'intérieur du vagin chez une patiente vierge et regarder à l'intérieur.

(11:36 - 12:06)

Parce que des fois, surtout les petites filles, on peut avoir un problème de corps étranger qui peut être introduit à l'intérieur du vagin et donner des infections, comme on peut avoir des tumeurs, donc utérines ou vaginales ou des parties molles. Et on a besoin d'aller voir à l'intérieur du vagin de la patiente. C'est clair? Oui, madame.

Merci. Très bien. Je vois maintenant vos questions.

(12:11 - 12:46)

Alors, est-ce que le spéculum permet d'ouvrir le col de l'utérus? Ce n'est pas le spéculum normal parce que le spéculum, c'est ça, c'est ce que je vous ai montré. C'est ça. C'est un bivalve qu'on introduit dans le vagin pour voir à l'intérieur du vagin.

(12:46 - 13:26)

Et ça va nous permettre de voir le col, mais ne nous permet pas de nous introduire dans le col. Pour aller voir un petit peu dans le col et on va juste voir la partie ondo-cervicale, on peut utiliser un spéculum qui s'appelle le Cougan, qui est un spéculum particulier. Donc, on doit mettre le spéculum vaginal, puis introduire le spéculum de Cougan qui est comme une pince qui va un peu écarter les lèvres du col pour pouvoir voir un petit peu à l'intérieur du col.

(13:26 - 15:38)

Regardez, ça c'est le spéculum qu'on utilise pour l'examen. Il nous permettra juste de voir à travers le vagin, de voir le col qui est là. Il ne peut pas rentrer ici.

Alors les valves, ils sont l'une ici et l'une là. La même chose, regardez, il y a une valve ici et une valve là et on voit le col à travers. Tout ça, c'est la paroi vaginale.

La paroi vaginale, c'est quand même quelque chose qui est assez long et on a besoin de ce spéculum avec un petit peu entre les lèvres inférieures du col pour voir à l'intérieur. Vous voyez, le spéculum, il est là et on voit le col et son orifice. Donc, le spéculum normal ne permet pas d'ouvrir le col.

On ouvre le vagin pour voir à l'intérieur. Bon, pourquoi le sang de monstres à sang ne coagule pas? En fait, moi je n'ai pas donné cette information dans mon cours, mais il ne coagule pas parce que c'est quand même comme c'est du sang qui a été encastré, qui est resté pendant longtemps au niveau de la paroi de l'endomètre et que comme j'ai dit, c'est plutôt une esquamation de l'endomètre qui nous donne les menstruations, mais en plus parce qu'il y a des facteurs qui vont inhiber la coagulation à l'intérieur de la paroi endométriale. Mais si jamais on a un sénement trop abondant à cause de la présence d'une pathologie comme l'arychome qui donne ce qu'on appelle les ménorragies, c'est-à-dire des règles trop abondantes, on peut avoir des cahiers sanguins sans problème.

(15:45 - 16:43)

S'il vous plaît, si on a une femme qui consulte pour une masse au niveau du sein, est-ce qu'on doit aussi faire un examen de son appareil génital? Très bonne question. En fait, ce qu'il faut garder en tête, surtout pour les femmes qui sont un peu âgées, mais qui ont une activité sexuelle et qui sont dans les trentaines par exemple et plus, oui, il faut toujours proposer un examen gynécologique de façon systématique, surtout si c'est une patiente qui ne fait pas son dépistage, c'est-à-dire qu'il ne se fait jamais examiner ou il ne se fait pas examiner une fois par an, il ne fait pas son frottis cervico-vaginal de façon régulière. Et donc là, vous pouvez lui proposer de faire aussi un examen gynécologique.

(16:44 - 17:32)

De la même façon que si la patiente vient pour un examen gynécologique, de l'appareil génital, parce qu'elle a des leucorrhées, parce qu'elle a une prurite, c'est-à-dire qu'elle gratte, ou encore parce qu'elle a des troubles musculaires et que vous faites l'examen gynécologique, il ne faut jamais oublier de faire la palpation des seins, parce qu'elle fait partie de l'examen gynécologique. Tout ceci pour ne pas passer à côté d'un module, dans le deuxième exemple, d'un module du sein qu'elle n'a pas palpé elle-même et aussi pour ne pas faire perdre à la patiente la chance de venir vous voir et de découvrir une pathologie débutante au niveau de son col, par exemple. Donc, vous pouvez demander à faire votre examen gynéco et faire le frottis.

(17:33 - 17:53)

Et à ce moment-là, vous pouvez découvrir une lésion très cancéreuse et vous pouvez lui proposer le traitement. Et là, vous l'aurez découvert, c'est un cancer invasif. Donc, je vous encourage à proposer aux patientes de faire un examen gynécologique, même si elle arrive pour autre chose.

(17:53 - 18:03)

Sachez qu'elle peut refuser, c'est sans droit. Bien sûr, on ne fait jamais quelque chose sans l'accord de la patiente. Maintenant, il y a des situations où elle vient vraiment pour autre chose.

(18:03 - 18:20)

Elle a de la douleur abdominale, elle a des troubles digestifs, etc. Et qu'elle arrive dans un centre de santé ou chez un médecin de famille. Normalement, elle habite dans son quartier ou bien il la connaît, etc.

(18:20 - 19:06)

Mais il se rend compte qu'elle n'est pas venue pour des examens réguliers de son appareil génital. Il peut aussi lui proposer de faire un examen en spéculum et éventuellement faire le

frottis cervico-vaginal, qui est le dépistage du cancer du col, et aussi de faire une palpation des seins pour le dépistage du cancer du sein. Alors, ceci rentre dans le cadre de la fonction bien connue du médecin généraliste, du médecin de famille, de ne pas se limiter à traiter ce qui est pathologique maintenant, et d'assurer aussi tous les gestes ou toutes les stratégies de dépistage qui doivent être réalisées chez la population.

(19:12 - 19:45)

Alors, la question... Si on suspecte une infection chez cette femme, est-ce qu'on a le droit de faire intervenir son mari aussi? Faire intervenir, c'est-à-dire quoi intervenir? Faire intervenir son mari pour diagnostiquer s'il s'agit d'une infection qui est sexuellement transmise chez cette femme. On va convoquer le mari pour un examen gynécologique, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, on peut.

(19:46 - 20:11)

On peut, oui, parce que les infections gynécologiques, souvent, c'est des infections sexuellement transmissibles, et il faut examiner le couple et il faut traiter aussi le couple. D'accord? Je vais prendre les questions parce que j'arrive à les voir maintenant sur un deuxième écran. Donc, il y avait déjà... On se demandait si... Alors... Voilà.

(20:14 - 20:32)

Les pertes fatales ne sont pas comptées dans la parité. Alors, attendez. Je vais reprendre avec vous.

Je savais que ça va un petit peu vous perturber dans ce sens. Voilà. Oui.

(20:33 - 20:49)

Ce n'est pas qu'elles ne sont pas comptées dans la parité. On a dit que la parité, c'est tout ce qui est au-delà de 20 semaines. D'accord? Et donc, si j'ai une perte fatale après 20 semaines, c'est une parité.

(20:50 - 21:07)

La perte patiente qui fait une mort fatale in utero à 5 semaines d'améliorée, c'est une parité. Ça va être une gestité plus une parité. Et si elle fait une grossesse avec une perte fatale avant 20 semaines, on ne va pas compter ça comme parité.

(21:07 - 21:40)

On va compter la gestité et puis on va dire que là, si c'est une seule grossesse, ça va être une gestité, mais zéro enfant vivant, mais avec soit une spontanée ou un apportement précoce ou tardif, etc. Mais au-delà de 20 semaines, c'est une parité, bien sûr. Alors, la question, est-ce que le spéculum permet d'étudier la paroi interne du vagin? Oui, bien évidemment.

(21:41 - 22:14)

Il va nous permettre, en sortant le spéculum, de dérouler la paroi du vagin. Et ainsi, on peut l'étudier bien évidemment. Alors, si on revient par exemple ici, regardez, je peux voir ici, c'est la paroi vaginale.

(22:15 - 22:45)

Ça et là. Et en sortant le spéculum, je garde l'œil pour voir ce qui se passe derrière les valves du spéculum. D'accord? Alors, dans quelle partie du cycle les leucorrhées sont physiologiques? En fait, à ce moment-là, c'est plutôt de l'angulaire cervicale, mais on peut aussi dire que c'est des leucorrhées physiologiques.

(22:45 - 23:09)

C'est surtout la période péri-ovulatoire. C'est la période autour de l'ovulation, c'est-à-dire vers 12, 13, 14 et 15, 15e jour du cycle. Donc là, on peut avoir des sécrétions vaginales qui proviennent du col utérin, parce que la glaire cervicale devient abondante, devient fluide, devient moins visqueuse.

(23:10 - 23:27)

Et donc, la patiente va la sentir un peu liquidienne. Et ceci est fait dans le sens, regardez par exemple dans cet exemple, regardez ici. Vous voyez quelque chose qui sort de cet orifice, un peu de liquide.

(23:27 - 23:36)

C'est de la glaire. Elle doit être transparente. Elle doit être inodore, c'est-à-dire qu'on ne sent aucune odeur ou aucune mauvaise odeur.

(23:36 - 23:45)

Et elle ne doit pas irriter la patiente. C'est-à-dire que pour des leucorrhées pathologiques, ça va donner une irritation. Elle va sentir comme des brûlures.

(23:45 - 24:42)

Elle va sentir le besoin de gratter. Elle va se sentir un peu irritée. Ça va devenir rouge.

Là, c'est pathologique. Et quand ça n'irrite pas, que c'est transparent et que c'est fluide et sans odeur, c'est physiologique et il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, pourquoi la salpallographie se fait pendant la première partie du cycle? Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît la réponse? Oui? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Pourquoi la salpallographie se fait au début du cycle? Éviter d'irriter une grossesse qui est encore méconnue.

(24:44 - 25:04)

Oui, bien évidemment, c'est ça la cause. C'est-à-dire que quand on est dans la première partie du cycle, c'est que, obligatoirement, cette patiente vient d'avoir ses règles, et donc elle n'est pas enceinte. Et qu'on n'a pas dépassé la période de l'ovulation et donc de la fécondité.

(25:05 - 25:19)

Et donc, on est sûr que cette patiente n'est pas enceinte. Et même pas un petit peu au début de grossesse. Parce que vous imaginez, si on met du produit de contraste dans la cavité, alors qu'il y a une grossesse.

(25:21 - 25:53)

Et là, c'est un produit de contraste qui émise pression, qui pousse avec un peu de pression pour que la cavité s'ouvre et se colore avec le produit de contraste. Donc, vous imaginez, s'il y a une grossesse, on va l'appuyer. Et en plus de ça, même si elle reste vivante et avec l'exposition à ces irradiations, parce que là, il y a plusieurs clichés qui sont pris dans l'hystérosymphanographie, qu'on risque d'avoir des malformations majeures.

(25:54 - 26:24)

Donc, c'est obligatoire d'avoir ou de faire toutes les explorations endo-cavitaires dans la première partie du cycle. Que ce soit l'hystérosymphanographie, que ce soit l'hystérocopie, que ce soit l'hystérosophonographie, c'est-à-dire qu'on injecte du sérum salé dans la cavité et on regarde avec l'hystérogographie. Tout ça doit se faire dans la première partie du cycle, c'est-à-dire juste après la fin des règles.

(26:26 - 27:56)

Bien évidemment, on ne peut pas le faire pendant la période des règles non plus, parce que là, on va faire refluer le sang des règles vers les trompes et il peut y avoir des cellules endométriales qui vont se greffer sur le péritoine et ça va donner ce qu'on appelle l'endométriose péritoniale. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors là, c'est pour la mammographie, c'est-à-dire le moyen d'imagerie auquel on peut explorer le sein. Donc c'est des rayons X. Et le fait que les seins soient un organe superficiel ou sous-cutané, ça rend un peu plus facile l'exploration radiologique aux rayons X, parce que vous voyez comme ici, on essaie de tirer le sein et de le mettre contre la cassette, c'est-à-dire de l'écraser un peu de façon à ce qu'il soit aplati et les rayons vont passer de haut en bas, comme vous voyez ici, et l'image sera sur la cassette ici.

(27:57 - 28:40)

Ceci veut dire que tous les cadrans supérieurs et inférieurs vont être superposés et toutes les lésions qu'on va voir sur ce cliché, elles vont apparaître soit externes, soit internes. Nous, on regarde, c'est l'image qu'on voit, et toutes les lésions qu'on peut voir ici, ça va être des lésions du cadran externe, des cadrans externes et là, c'est ceux des cadrans internes. On ne peut pas

dire est-ce que c'est le cadran supérieur ou externe ou est-ce que c'est le cadran inférieur ou externe, parce qu'ils sont superposés.

(28:41 - 29:38)

Pour savoir quel cadran supérieur ou inférieur, on doit obligatoirement faire une incidence plutôt de profil, c'est-à-dire qu'on prend le sein de façon verticale et donc la cassette de l'imagerie ou la réception de l'image se trouve au milieu et on a les rayons qui viennent par là. Donc là, les cadrans externes et internes sont superposés et l'image qu'on voit, c'est celle-là, et à chaque fois qu'on va trouver quelque chose en haut, ça veut dire que ça correspond au cadran supérieur et en bas, ça correspond au cadran inférieur. Avec le premier cas, on avait dit externes et internes, et là, supérieur et inférieur, on peut facilement dire que par exemple, la lésion, si elle se trouve ici, elle est supérieure et externe.

(29:39 - 31:09)

D'accord? Alors, il y a une question. Quelles sont les zones androgéniques? Là, vous parliez de l'hercétisme, n'est-ce pas? Les zones androgéniques par rapport au poil, par rapport aux patientes qui ont un peu de poil sur leur peau, ce sont toutes les zones que normalement les femmes ne devraient pas avoir de poil dessus, mais que plutôt c'est les hommes qui ont ça, par exemple au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax, au niveau du dos, au niveau des faces internes des cuisses, tout ça, c'est des zones androgéniques que théoriquement, les femmes ne devraient pas avoir de poil dessus, et que si on retrouve, et aussi au niveau du visage et du menton, là aussi, c'est une zone androgénique, la présence de poil sur cette zone-là pourrait signifier qu'il y a ce qu'on appelle une hyper-androgémie qui peut être liée soit à des horaires polycystiques, soit à d'autres problèmes de sécrétion d'hormones masculines dans la testostérone, soit par l'ombre, soit par l'estomac, et donc là, il faut balancer ça. Réexpliquer quoi sert la courbe ménothermique.

(31:09 - 32:02)

D'accord. En fait, ça ne sert plus à grand-chose entre nous. Ça ne sert plus à grand-chose dans le sens où son utilisation est très difficile, que c'est très astreignant par rapport à la passante, de prendre sa température de façon quotidienne au lit avant le réveil, et autrefois, elle nous donnait quand même une idée sur l'évolution de la température, et ainsi on peut savoir si c'est un cycle ovulatoire ou pas ovulatoire.

(32:03 - 32:21)

D'accord? C'est ça les renseignements qu'on peut donner. Donc, quand la courbe est biphasique, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est basse, et en fait, c'est une toute petite surélévation de la température. Ce n'est pas phénoménal.

(32:21 - 32:41)

Ça peut être un demi-degré, un degré, et pas plus. Et donc là, on sait que l'ovulation a eu lieu, et que nous avons une phase lutéale qui est normale. Quand cette ascension ne se fait pas, c'est qu'il n'y a pas d'ovulation, pas d'un cycle anovulatoire.

(32:42 - 33:13)

Aussi, elle nous donne une idée sur la phase lutéale qui était là, c'est-à-dire la phase à partir de l'ovulation jusqu'aux menstruations. C'est une phase dans laquelle il y a une succession de la progestérone, ce qu'on appelle le corps jaune. Le corps jaune, c'est ce qui reste de l'ovocyte, ou du follicle, après l'expulsion de l'ovocyte.

(33:13 - 33:41)

Et donc, ce corps jaune, il a une fonction, il doit sécréter obligatoirement de la progestérone pour avoir une longueur du cycle normal, et aussi pour que si jamais il y a une prothèse, qu'elle se maintienne. La progestérone permet de maintenir la grossesse. Donc, avoir une phase lutéale trop courte, ça définit ce qu'on appelle l'insuffisance lutéale.

(33:41 - 34:03)

Et souvent, il y a des femmes qui prennent des pilules à cause de ça et qui ont des cycles perturbés à cause de ça. Et donc, elle devrait être suppléée en progestérone, justement. Et puis, parfois, on peut avoir ce plateau qui est trop prolongé et qui ne descend jamais.

(34:04 - 34:33)

Là, c'est qu'on est dans une situation de pilule. Maintenant, sur le plan pratique, sachez que c'est une technique qui est historique et qui a existé pendant longtemps avant qu'il n'y ait la possibilité de suivre l'ovulation par l'échographie, parce que là, on peut demander à la patiente de venir à J-10 et de son cycle. Et on regarde s'il y a une molécule qui augmente de taille et si on arrive à avoir une molécule dominante.

(34:34 - 34:44)

Et puis, on lui demande de venir deux jours plus tard. On voit qu'il grossit et qu'il commence à avoir la taille suffisante pour l'ovulation. Et après encore deux jours, on la revoit.

(34:44 - 34:49)

Cette molécule n'est plus là. Il a été expulsé. Et il y a le corps jaune.

(34:49 - 35:11)

Donc là, on est sûr que l'ovulation s'est déroulée. D'ailleurs, quand on a cette molécule mature qui arrive à la bonne taille, on compte à la patiente de faire des rapports les jours suivants afin de pouvoir avoir une grosse taille. D'accord ? Et donc, à peu près, on n'utilise plus cette courbe

ménothermique.

(35:12 - 36:33)

Mais dans les situations où on n'a pas accès à l'échographie de façon régulière, on peut l'utiliser pour localiser l'ongulation et aussi pour identifier la présence de cette onglulation des jambes. D'accord ? Vous avez d'autres questions ? Alors, il y a une question qui dit, « Pourquoi lors de la pratique, on va mettre des gants non stériles ? » En fait, ta question veut dire qu'est-ce qu'on va mettre les gants ou pas les gants ou bien est-ce qu'ils doivent être stériles ou pas stériles ? Mettre les gants pour le praticien, c'est obligatoire parce que vous allez être en contact avec les sécrétions génitales de la patiente et donc les risques d'infection ou de contamination du médecin ou du praticien sont là. Vous ne pouvez pas toucher les mains nues des sécrétions du patient, même si vous allez mettre le spéculum.

(36:33 - 37:00)

D'accord ? Maintenant, est-ce que c'est stérile ou pas stérile ? On peut vous dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser des gants stériles, mais par contre, vous allez utiliser un spéculum stérile. D'accord ? Soit un spéculum stérile à usage unique et il est en plastique généralement soit un spéculum métallique comme ce que je vous ai montré. Je pense sur l'autre.

(37:00 - 37:14)

Voilà. Et métallique qui est comme celui-là et qui est stérilisable. Mais pour chaque façon, il faut avoir un spéculum stérile.

(37:14 - 37:51)

Pourquoi vos gants ne devraient pas... Ce n'est pas nécessaire que ce soit des gants stériles, il faut que ce soit des gants propres, évidemment, parce que regardez, vous n'allez pas mettre les mains... C'est-à-dire, vous ne risquez pas de transmettre grand-chose parce que déjà, le vagin est en contact libre avec le milieu extérieur. Donc, ce n'est pas une zone stérile à 100%. Et donc, le plus important, c'est que ce soit des gants propres d'examen et que, bien sûr, que ce soit à usage unique.

(37:51 - 38:15)

Pas besoin d'utiliser des gants stériles pour l'examen. Par contre, si je vais mettre un stérilet, ou si je vais faire un stérile, c'est-à-dire que je vais m'introduire dans la cavité utérine, là, je vais faire attention pour utiliser des gants stériles. C'est parce que, tout simplement, le vagin, ce n'est pas un organe stérile, c'est un organe qui est propre.

(38:16 - 39:05)

Et donc, normalement, on n'a pas besoin d'un gant stérile. Alors, la question 2. Attendez un peu. Ce n'est pas nécessaire que ce soit stérile, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des gants

propres.

(39:06 - 39:38)

Je pense que j'ai perdu une question, ou bien... Oui. D'accord. Alors, pourquoi l'infection de la taille contredit l'héroskopie? Eh bien, comme je viens de le dire, l'héroskopie ou toute manipulation à l'intérieur de la cavité devrait se faire de façon stérile, parce que la cavité utérine, elle est stérile, et elle est fermée au niveau du col par la glaire cervicale.

(39:38 - 40:04)

Donc, si on force la cavité utérine, et on met un hystéroscope pour regarder à l'intérieur, il faut qu'on travaille... Donc, voilà pour l'hystéroscope, regardez. On introduit l'hystéroscope dans la cavité pour rentrer à l'intérieur de la cavité utérine. Par contre, pour le vagin, on s'arrête ici.

(40:04 - 40:13)

On regarde. Pas de problème, en fait. On peut même faire le toucher vaginal avec des gants propres, il n'y a pas de souci.

(40:13 - 41:00)

Et donc, là, quand on manipule à l'intérieur de la cavité utérine, là, c'est un peu plus dangereux, parce que la cavité doit être stérile. Si elle est contaminée, on peut avoir ce qu'on appelle une endométrite, qui est une infection génitale haute, qui nécessite une antibiotérapie et qui peut s'aggraver par une infection du pénis en entier. D'accord? Et puis, quand il y a une infection génitale, même si c'est seulement une vaginite ou une serre lucide, on ne devrait pas faire de manipulation à l'intérieur de l'utérus, parce qu'on va faire rentrer ce germe à l'intérieur de la cavité, et là, on risque de faire une infection assez grave.

(41:00 - 41:18)

C'est comme si... Vous êtes encore dans le cadre, vous connaissez. C'est comme si on parle d'une infection... Par exemple, c'est des infections qui sont quand même sévères. Ils peuvent donner de la fièvre, ils peuvent donner une septicémie, c'est-à-dire que les bactéries passent dans le sang, etc.

(41:19 - 42:26)

Donc, on ne doit pas faire de manipulation à l'intérieur de l'utérus. Là, je parle de l'endométrie, mais aussi de l'hystérographie par exemple. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, là, c'est ce qu'on appelle la ptéoscopie, ou la laparoscopie, c'est-à-dire que c'est un moyen aussi dans lequel on utilise une caméra.

(42:26 - 42:43)

Quand on introduit comme ça, la caméra, elle est là. Pour l'introduire, regardez ça, c'est la paroi abdominale, ça c'est le dos de la patiente qui est couchée en bas. Et là, c'est la région pelvienne, on reconnaît l'utérus, l'ovaire et le rectum.

(42:45 - 43:32)

Et donc, cette caméra, on l'introduit dans l'utérus, on parle d'incision, mais il faut obligatoirement gonfler la cavité péritonéale, c'est-à-dire qu'on doit remettre du gaz. Dans ce même trocart dans lequel on introduit la caméra, il y a une source de gaz qui fait gonfler l'abdomen pour que la paroi remonte et on a un espace ouvert dans lequel on peut voir les organes. Parce que sinon, la paroi va être affaissée contre le dos et on ne peut pas passer avec notre optique. Donc, on gonfle, on met l'optique et puis on regarde et on peut voir des choses comme ça.

(43:33 - 44:03)

Regardez, il y a l'utérus par exemple ici en avant, il y a les trompes qui sont là, il y a l'ovaire qui est là. Donc, vous voyez qu'elle a... c'est-à-dire qu'elle a ce fait en ovaire, regardez. Vous voyez, elles sont un peu aplaties avec un bord interne et un bord externe et qui sont attachées à l'utérus.

(44:03 - 44:18)

Regardez les ligaments utéro-ovariens. Il y a les trompes qui sont là, regardez. Ce sont des petits tubes mais qui sont vraiment millimétriques et le pavillon est par là.

(44:22 - 44:59)

Ces tubes permettent de ramener l'ovocyte qui est excité de l'ovaire vers la région oviductaire où la fécondation serait. Et par la suite, la fécondée va revenir vers la cavité utérine. Alors, il y a une question qui demande par rapport au toucher vaginal.

(44:59 - 45:14)

Voilà le toucher vaginal, regardez. Voilà. Est-ce qu'on peut toucher le col utérin sans appuyer sur l'abdomen? Oui, vous pouvez le faire.

(45:15 - 45:46)

Alors, le fait d'appuyer sur l'abdomen, ce n'est pas pour toucher le col. Bien sûr, c'est une façon de faire si le col est très loin et que vous n'arrivez pas à le toucher. Vous pouvez pousser avec vos doigts à l'abdomen et ainsi rapprocher l'utérus de la paroi de votre doigt.

(45:46 - 46:14)

Mais on peut toucher le col sans appuyer sur l'abdomen. Pourquoi on appuie sur l'abdomen?

C'est surtout pour voir la taille de l'utérus et savoir si c'est un utérus de taille normale et généralement rétro-synchidaire, c'est-à-dire que vous ne le palpez pas plus haut. Donc, si vous le palpez un peu plus haut, voilà.

(46:15 - 46:32)

Donc, si vous palpez le dos de l'utérus plus haut ici, ça veut dire que c'est un gros utérus. C'est un utérus qui est augmenté de taille. Mais si quand vous palpez, vous vous retrouvez derrière la synchrise, là, vous avez une taille normale.

(46:33 - 46:45)

Donc, vous voyez, c'est toujours en rétro-synchidaire. Maintenant, là, regardez la synchrise qui est là, mais on voit quand même que l'utérus est un peu plus grand. Là, on doit parler de la taille de l'utérus.

(46:45 - 47:22)

Donc, le toucher vaginal couplé à la palpation abdominale, il est nécessaire surtout la taille de l'utérus. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'une infection du vagin peut se propager spontanément vers l'utérus ou vers les ovaires? Oui, bien évidemment. Une infection non traitée, d'abord, elle peut facilement passer à l'intérieur de l'utérus à travers le canal cervical.

(47:25 - 47:55)

Et puis, puisque l'utérus communique à travers les trempes avec le pelvis, avec tout ce qui se passe à l'intérieur du pelvis, comme je vous ai montré, attendez, je vais vous montrer ici. Donc, c'est très simple. Donc, imaginez que l'infection est venue d'en bas et qu'elle est arrivée au niveau de la cavité à l'intérieur de cet utérus, mais vous avez les trempes qui communiquent avec la cavité de l'intérieur.

(47:56 - 48:30)

Les gens peuvent monter jusqu'ici et se propager dans tous ces espaces pelviens. Et là, on parle d'une pelvipéritose, c'est-à-dire une infection et une inflammation du pelvis avec son péritoine. Et là, c'est surtout chez des patients qui ont un comportement sexuel à risque et qui ont des infections à répétition et qui ne sont pas correctement traitées.

(48:31 - 48:54)

Et pour réinfecter H3, il y a des germes qui vont répétériser et donc entraîner une infection haute. Ça s'appelle une infection génitale haute. Mais le terme d'un grand, c'est plutôt que vous allez trouver une maladie pelvienne inflammatoire.

(48:55 - 49:52)

Ça va devenir ce qu'on appelle une maladie pelvienne inflammatoire parce qu'à cause d'un certain nombre de germes particuliers, surtout le chlamydie, même si on traite par les antibiotiques, on arrête l'infection bactérienne, il y a un syndrome inflammatoire qui s'installe, qui peut donner des adhérents, c'est-à-dire que les trans vont coller quelque part ici avec le péritoire et ça, ça va donner des obstructions de la tronche et ça peut donner des problèmes d'infertilité après. Donc, toutes les infections génitales ou vaginales doivent être traitées correctement. Il faut traiter le couple à chaque moment, c'est-à-dire traiter la femme et le mari et ce qui sera le garant des effets secondaires à long terme sur la fertilité.

(49:52 - 50:08)

Regardez par exemple sur ces images là, en bas. Là. Images, voilà, ici.

(50:08 - 50:28)

Regardez ça, c'est l'utérus, la trempe et l'omphère. Mais ça, c'est pas une trempe normale, c'est une trempe qui est touchée vers l'extrémité à cause justement de ces infections. Quand les infections se répètent et arrivent ou n'y coupent rien, ça va boucher la trempe et la trempe va se dilater de façon à ce que ça nous donne ce qu'on appelle l'hydrosalpinx, comme ici.

(50:29 - 51:08)

Regardez, ça c'est l'utérus, ça c'est une autre trempe et ces trempes-là, elles sont bouchées de leur extrémité et elles sont pas comme celle-là qui est un peu fluide, non. Elles sont dilatées, c'est l'hydrosalpinx et ça veut dire qu'elles sont bouchées et donc elles ne nous laisseront pas passer l'homocyte pour se faire fêter. Alors, pour les améliorer, c'est pas avec moi, c'est avec le professeur Aboul Falah, c'est avec lui qu'il faut discuter de ce qui est là.

(51:16 - 51:58)

Pourquoi l'examen d'essence est de préférence en fin du cycle? Pourquoi j'ai mis ça en fin du cycle? Non, il ne faut pas que ça se fasse en fin du cycle, il faut que ça se fasse au tout début du cycle, c'est-à-dire quelques jours après les règles. Alors, j'ai mis pas en fin du cycle, mais en fin de règle. En fin de règle, on est au début du cycle, pas à la fin du cycle.

(51:59 - 53:07)

La fin du cycle, c'est juste avant les règles, pas la fin du cycle avant. Pourquoi il ne faut pas le faire en cette période-là, c'est-à-dire la période juste avant les règles, parce que là, il y a une imprégnation pérennienne et les seins sont gonflés, il y a une rétention de dos. Vraiment, les filles, elles savent ça, c'est-à-dire avant les règles, les seins sont gonflés, elles sentent dur et ça fait mal, et quand vous allez palper, vous n'allez pas sentir, ils sont tendus, vous n'allez pas bien sentir la palpation.

Donc, il faut attendre l'arrivée des règles, quelques jours après le début des règles ou même à

la fin des règles, on fait l'examen des seins, là, elles sont moins tendues, elles sont relâchées et on peut sentir la palpation correctement. J'ai répondu à Belbatot, donc c'est en fin de règle et pas en fin du cycle. Malheureusement, le palpé abdominal est systématiquement pathologique.

(53:08 - 54:07)

Voilà, je vous ai expliqué pour les règles. Donc, systématiquement pathologique, non, mais il faut conclure que vous avez un gros utérus. Quand vous avez un gros utérus, il faut voir pourquoi.

Ça peut être une grossesse, ça peut être autre chose, un fibrome, une masse, ça peut être juste le fait qu'une patiente a accouché plusieurs fois et que son utérus ne revient pas à la taille initiale, il reste un peu plus gros. Et donc, quand vous trouvez ça à l'examen clinique, vous concluez un utérus augmenté de taille, vous devez faire une échographie par la suite pour savoir pourquoi. Et donc, quand vous faites l'échographie, vous allez bien regarder soit vous avez une grossesse à l'intérieur, soit vous avez un fibrome, soit vous avez tout simplement un gros utérus, mais dans l'échostructure, elle est normale, c'est-à-dire le myomètre est normal, la cavité utérine est normale.

(54:08 - 54:36)

Et donc, il n'est pas systématiquement pathologique, mais c'est un signe clinique qui doit être exploré tout simplement. Alors, problème de gants stériles ou pas stériles, ça vous perturbe. Ce n'est pas que c'est interdit de mettre des gants stériles.

(54:37 - 54:47)

Si vous les avez, vous les utilisez. Mais les gants stériles, elles sont plus chères que les gants propres. D'accord? Mais quand on dit non stériles, ça ne veut pas dire qu'elles sont sales, vos gants.

(54:48 - 56:13)

D'accord? Ce ne sont pas des gants propres d'examen. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser des gants stériles qui sont plus chers, tout simplement. Et bien évidemment, vous devez avoir des gants.

Vous ne pouvez pas faire l'examen sans gants, tout simplement. Et parce que l'examen en spéculum, il n'y a pas de manipulation à l'intérieur de la cavité utérine, et donc, on peut le faire avec des gants propres. Dans quel cas l'examen radiologique serait responsable? Alors, vous êtes débutant en en génie, et vous allez comprendre au fur et à mesure dans qui on va faire.

Donc, pour HIPAA, vous allez vous allez comprendre au fur et à mesure que les examens radiologiques sont des examens dites para-cliniques. C'est des examens qui sont indiqués après avoir fait vos examens. Et c'est quand vous trouvez des anomalies à l'examen clinique,

que vous demanderez l'aide.

(56:14 - 56:39)

Comme je viens d'expliquer maintenant, quand je fais la palpation de l'utérus, et je trouve que c'est un l'utérus augmente. Eh bien là, oui, je vais demander une échographie, ou bien je vais la faire moi-même, si j'ai une écologue, par exemple, ou même certains généralistes peuvent faire une échographie très bien simple. Donc, je vais revoir pourquoi cet utérus a augmenté le time.

(56:40 - 57:02)

Je peux aussi palper et trouver une trace latéro-utérine, quelque chose qui est palpée à côté de l'utérus. Et là, je vais devoir aussi demander une échographie pour voir qu'est-ce qui se passe à côté de l'échographie, à côté de l'utérus. La même chose pour l'estin.

(57:03 - 57:31)

Je demanderai de l'imagerie si jamais j'ai un module que je palpe ou j'ai une masse, par exemple, etc. Bien évidemment, l'imagerie pourrait être demandée. L'imagerie pourrait être demandée aussi dans le cas du dépistage, par exemple, au niveau du sein.

(57:32 - 58:46)

Et le dépistage, c'est la recherche de pathologies néoplasiques ou très néoplasiques avec un moyen radiologique ou un moyen biologique ou psychologique, avant qu'il n'y ait des signes cliniques décelables à l'examen clinique. C'est-à-dire prenons, par exemple, je peux faire une mammographie chez une patiente d'un certain âge, au-delà de 45 ans, même si son examen clinique est strictement normal. Pourquoi? Parce que là, je suis dans une autre optique, c'est-à-dire que je suis en train de faire un dépistage en cherchant des lésions infracliniques, c'est-à-dire des lésions inférieures à un centimètre, comme par exemple ici, regardez, cette image-là, je peux ne pas la palper quand je fais la palpation parce qu'elle est très petite, inférieure à un centimètre dans un gros cancer du sein, je ne vais jamais la palper, mais elle est là et elle va grossir et si je ne la vois pas précocement, ça va être un cancer du sein avancé et le traitement serait encore plus difficile.

(58:47 - 59:17)

Donc, je fais une imagerie de dépistage, ça s'appelle une mammographie de dépistage et elle nous permet de voir des lésions préconçues. Le dépistage est généralement organisé dans un protocole pour qu'on sache quelles sont les personnes qui nécessitent de faire ce dépistage. Pour le sein, en général, c'est au-delà de 45 ans qu'on devrait faire une mammographie et la répéter tous les deux ans.

(59:19 - 1:00:25)

J'espère que j'ai répondu. La même chose pour le scanner, la même chose pour l'IRM, on peut

les demander, mais quand on retrouve des anomalies, le scanner et l'IRM sont bien, et surtout l'IRM est la plus performante au niveau de Belleville, c'est quand on trouve des anomalies à l'échographie déjà. Je fais l'examen clinique, je peux trouver des anomalies, après, je vais faire l'échographie, à l'échographie, je peux retrouver d'autres anomalies, soit l'échographie nous permet de dire que c'est une pathologie X ou Y et on est sûr et c'est bon, sinon on n'est pas sûr si on a une pathologie complète qu'on veut faire, par exemple, si c'est un cancer, ce qu'on appelle le bilan d'extension, c'est-à-dire on cherche, est-ce que ce cancer est limité ou bien il dépasse l'utérus vers un autre organe, et bien là, on demandera l'IRM.

(1:00:25 - 1:01:02)

Donc, vous voyez, c'est quand même escalade de l'examen clinique. Par clinique, on commence par l'échographie en général ou si c'est bon, le poumon, sûrement on vous a parlé, on va faire la radiothorax et si on n'arrive pas à dénoncer on va faire le scanner, on va faire l'IRM, etc. Est-ce que l'examen au spéculum est douloureux? En fait, il pourrait être douloureux si vous ne le réalisez pas en douceur.

(1:01:03 - 1:01:26)

Alors, c'est très important. Je pense que j'avais mis une plaque où on a écrit beaucoup de choses sur l'examen au spéculum. Voilà, ça ce sont des recommandations françaises.

(1:01:27 - 1:03:48)

Vous devez lire de façon très attentive pour voir. Alors, ce qui est important, c'est que il faut le faire après avoir encore mis la patiente, que ce soit dans des conditions qui respectent l'intimité de la patiente pour qu'elle soit relâchée parce que elle est crispée et contractée, c'est sûr qu'elle va avoir mal à l'introduction de l'examen. Et puis après, quand on a publié les exercices, on s'est regardé introduire le spéculum en respectant l'anatomie, donc on va le balancer vers le bas, et l'ouvrir délicatement en veillant d'avoir le coton délicatement pour faire l'examen délicatement pour que ce ne soit pas douloureux parce que quand même c'est une zone intime qui est assez sensible et si on y va de façon mécanique et rapide ou un peu brusque, évidemment on va faire mal à la patiente et le malheur serait que cette patiente va avoir un très mauvais souvenir et qu'elle ne voudrait plus jamais revenir faire un examen spéculum et elle risque d'échapper au dépistage et de revenir plus tard en enseignant et on découvre un cancer vital.

On trouve encore des choses comme ça dans notre population, qu'en faisant un mauvais souvenir de l'examen gynécologique, elles vont refuser de revenir et c'est très malheureux. Donc je voudrais bien que vous reteniez d'amble et que l'examen, surtout au spéculum et au toucher vaginal, c'est très délicat, c'est un organe sensible, vraiment être respectueux de l'intimité de la patiente et être le plus poli, c'est-à-dire vraiment compatible, savoir qu'elle va avoir honte, que ce n'est pas simple sur la médecin-homme, qu'elle doit se déshabiller, etc. Ce n'est pas simple, il faut gérer justement l'intimité de la patiente de façon à ce qu'on puisse la mettre en confiance et qu'elle soit relâchée et comme ça on peut faire l'examen de façon

délicate et ne pas lui faire mal.

(1:03:57 - 1:05:11)

Alors, vous avez d'autres questions? Alors, pour revenir à tout ça, donc là, en haut à gauche, ça a l'air normal, vous voyez, ça c'est l'exocol, il est bien révisé, vous voyez là, c'est de la glaire, c'est des écrins, et vous avez l'orifice, cet orifice pourrait être allongé, mais c'est une patiente qui a déjà fait plusieurs fois. Ici, vous voyez que c'est un col qui est un peu gros, que l'orifice est un peu horizontale, ce serait probablement déchiré, donc en plus, il y a de la rougeur et ici, c'est juste un ectropion, c'est-à-dire que la patiente a une inversion de la musculature ontocervicale, puis vous avez tout ce qui est blanche après. Ici, c'est des bleues coréées qui ont l'air pas bonnes, elles ont l'air d'être pathologiques, parce que vous voyez, elles ne sont pas translucides, elles ne sont pas transparentes, et puis abondantes, elles sont un peu blanches, ça peut être du Candida, par exemple.

(1:05:12 - 1:05:48)

Là, on voit que la musculature est verte et tout, mais il y a cet élément-là central qui se surajoute au niveau de l'orifice cervical, et là, c'est l'aspect de colique, qui est une formation bénigne, une croissance bénigne de la muqueuse, et qu'on peut enlever facilement. Par contre, ici, par exemple, regardez ça, c'est la muqueuse exocervicale, comme celle-là. Au centre, vous voyez, il y a quelque chose qui saigne, qui n'est pas propre, et qui est surtout bourgeonnant.

(1:05:48 - 1:06:03)

C'est un aspect lié au chou-fleur. Si vous connaissez le chou-fleur, ça a l'air de ça. Un chou-fleur bourgeonnant, ça, c'est très suspect d'être un chou-fleur bourgeonnant.

(1:06:03 - 1:06:35)

La même chose ici, sauf que ici, on a comme une partie grignotée dans le col, et ça aussi, c'est pas grand. Je vais prendre encore une dernière question qui décroître. Pour l'enseignement, je pensais aussi que vous l'avez fait avec le professeur Beuffala, donc j'ai eu une autre question pour lui.